



MATERIAL DE APOIO TÉCNICO

Matriz de risco psicossocial

Probabilidade e severidade: como escolher, documentar e assumir o método de avaliação exigido pela NR-01.

ANTES DE COMEÇAR

Para que serve este material

Desde 26 de maio de 2026 a fiscalização da NR-01 sobre fatores psicossociais deixou de ser orientativa. Com ela veio uma pergunta que muita empresa ainda não sabe responder: com quais critérios vocês decidiram que este risco é alto e aquele é moderado?

A resposta a essa pergunta é a matriz de risco. Ela não é um anexo estético do PGR. É o instrumento que traduz o que a empresa descobriu sobre suas condições de trabalho em uma ordem de prioridade defensável.

Este documento organiza os dois conceitos que sustentam qualquer matriz, probabilidade e severidade, mostra por que não existe um modelo obrigatório, apresenta o modelo que a Escutaris recomenda e explica o que precisa estar escrito para que a escolha da empresa se sustente diante de uma auditoria.

O QUE VOCÊ ENCONTRA AQUI

1. Por que não existe matriz oficial, e o que a norma exige no lugar disso
2. Severidade: o tamanho do dano que o fator pode causar
3. Probabilidade: a chance de esse dano acontecer
4. O que questionário, escuta e observação de fato medem
5. Por que a matriz precisa ser assumida pela equipe técnica de SST
6. Por que a decisão sobre os valores é coletiva
7. Como as medidas de controle já existentes mudam o resultado
8. O modelo 5×5 recomendado pela Escutaris, com as tabelas completas
9. Três casos aplicados do começo ao fim
10. Checklist do que precisa estar escrito no PGR

O material é de apoio técnico. Ele não substitui a análise ergonômica preliminar, a avaliação de cada posto nem o julgamento de quem assina o programa. Serve para que essa decisão seja tomada com critério declarado.

Não existe matriz oficial

Esta é a primeira coisa a esclarecer, porque quase toda dúvida sobre matriz de risco psicossocial nasce da expectativa de que exista um modelo pronto, chancelado, que baste copiar.

Não existe. A NR-01 não prescreve escala, não define número de níveis, não impõe fórmula e não homologa modelo de fornecedor. Nem o Guia do MTE sobre fatores psicossociais, nem a ISO 45003:2021, nem a ISO 31000:2018 trazem uma matriz obrigatória.

O que circula no mercado é um conjunto de modelos legítimos e diferentes entre si. Alguns exemplos do que se vê na prática:

Modelo	Como funciona	Quando faz sentido
3 x 3	Três níveis de probabilidade e três de severidade, resultado de 1 a 9.	Organizações pequenas, primeira rodada de avaliação, equipe técnica ainda em formação no tema.
4 x 4	Quatro níveis em cada eixo, sem ponto médio, o que força a equipe a se posicionar.	Quando existe risco de todo mundo escolher o meio da escala por insegurança.
5 x 5	Cinco níveis em cada eixo, resultado de 1 a 25, com faixas de classificação.	Quando há dados de instrumento validado que sustentam distinções mais finas.
Com risco residual	Ao resultado bruto aplica-se um fator que representa a maturidade das medidas de controle já existentes.	Quando a empresa quer demonstrar o efeito das ações que já tomou e acompanhar a evolução ao longo dos ciclos.
Com regra de elevação	Determinadas combinações são promovidas a um nível acima do que o número indicaria, por decisão de critério.	Quando o dano potencial é irreversível e a empresa não aceita que ele caia em faixa de baixa prioridade.

O QUE A NR-01 EXIGE DE FATO

A norma não escolhe o modelo por você. Ela exige que a organização defina, de forma detalhada e expressa em documento, os critérios adotados para:

- **Severidade:** a magnitude do impacto que o risco pode gerar
- **Probabilidade:** a chance de o risco efetivamente se materializar
- **Níveis de risco:** as faixas que resultam do cruzamento dos dois eixos
- **Classificação:** como cada risco identificado é enquadrado nessas faixas
- **Tomada de decisão:** qual resposta cada faixa aciona, e em que prazo

A auditoria não pergunta se a matriz é a certa. Pergunta se ela está escrita, se foi aplicada de forma consistente e se quem assina consegue explicar por que os valores são esses.

Isso muda o que a empresa precisa produzir. Não é preciso caçar o modelo correto. É preciso escolher um modelo coerente com a realidade da organização, registrar essa escolha e usar sempre o mesmo em todos os fatores avaliados. Trocar de régua no meio da avaliação invalida a comparação entre setores, e é uma das inconsistências mais fáceis de identificar em uma fiscalização.

Severidade: o tamanho do dano

Severidade é a magnitude do dano que o fator de risco pode produzir, caso se materialize. É uma pergunta sobre gravidade potencial, não sobre frequência.

No campo psicossocial a severidade se organiza em três planos que precisam ser avaliados juntos.

Plano 1: saúde de quem trabalha

Ansiedade, depressão, burnout, transtornos do sono, quadros somáticos ligados ao estresse, transtorno de estresse pós-traumático de origem ocupacional, uso abusivo de substâncias e, nos casos extremos, ideação suicida. A ancoragem em CID-11 é o que dá objetividade a este plano: em vez de discutir se o sofrimento é grave, discute-se se ele já atingiu limiar diagnóstico.

Plano 2: segurança

Fatores psicossociais afetam diretamente a percepção de risco e a capacidade de manter comportamento seguro. Sobrecarga, fadiga e estresse crônico aumentam a chance de acidente. Este plano costuma ser esquecido nas avaliações psicossociais, e é justamente o que conecta o tema ao restante do PGR.

Plano 3: organização e passivo legal

Queda de produtividade, presenteísmo, absenteísmo, rotatividade involuntária, conflitos interpessoais, deterioração do clima, afastamentos por CID-F, ações trabalhistas, obrigação de registro no eSocial e exposição reputacional.

A DIMENSÃO QUE A MAIORIA DOS MODELOS ESQUECE

Existe um quarto elemento que não é um plano de impacto, mas modifica todos eles: a **reversibilidade**. Dois danos podem ter a mesma expressão clínica hoje e desfechos completamente diferentes. Um desconforto que se dissipa em duas semanas quando o estressor sai de cena não é o mesmo fenômeno que um quadro que exige tratamento por doze meses e pode deixar sequelas.

Por isso o modelo recomendado neste material trata reversibilidade como dimensão própria da severidade. Sem ela, a escala tende a achatar tudo no meio.

De onde vem o valor da severidade

Aqui está uma distinção que resolve boa parte da confusão em campo. A severidade **não é medida na empresa**. Ela vem da natureza do perigo e da literatura sobre o dano que aquele perigo produz. Assédio moral tem severidade alta porque a literatura clínica documenta os quadros que ele gera, não porque a empresa pesquisada é pior que as outras.

O que a empresa faz é confirmar em qual nível da escala aquele perigo se enquadra no seu contexto, usando indicadores objetivos como âncora: existem afastamentos por CID-F? Existem queixas formalizadas? Existem benefícios do INSS concedidos? Esses indicadores calibram a severidade. Não a inventam.

Probabilidade: a chance de o dano acontecer

Probabilidade é a chance de o fator de risco identificado efetivamente gerar dano à saúde, à segurança ou ao desempenho de quem está exposto.

Para riscos físicos e químicos a probabilidade sai de frequência de exposição, tempo de contato e dados estatísticos. Para riscos psicossociais a NR-01 traz critério próprio, no subitem 1.5.4.4.5.3, e ele tem duas pernas.

Componente 1: exigências da atividade de trabalho

Refere-se à intensidade, frequência e duração da exposição ao estressor organizacional. Quanto mais intensas e frequentes as exigências que geram o perigo, maior a probabilidade de dano. As perguntas de campo são:

- Com que frequência a pessoa é exposta ao perigo? Diariamente, semanalmente, de forma esporádica?
- Qual a intensidade da exposição? Pressão alta e constante ou pressão pontual?
- Quantas pessoas estão expostas? A equipe inteira, um turno, uma função?
- A exposição é contínua ou existem períodos reais de recuperação?

TRABALHO REAL, NÃO TRABALHO PRESCRITO

A avaliação precisa se apoiar no que acontece no dia a dia, não no que está escrito no manual de processos. Uma política de pausas que existe no procedimento mas que ninguém consegue usar porque a fila de atendimento não permite é trabalho prescrito. A probabilidade se calcula sobre o trabalho real.

Este é um dos pontos que a fiscalização verifica com atenção, e é onde a observação direta e a escuta se tornam insubstituíveis: nenhum questionário isolado revela a distância entre o prescrito e o real.

Componente 2: eficácia das medidas de prevenção já existentes

Barreiras que funcionam reduzem a chance de o perigo virar dano. Barreiras ausentes ou inoperantes aumentam essa chance. As perguntas de campo são:

- Existe medida preventiva para o perigo identificado?
- Se existe, ela está de fato implantada ou só documentada?
- As pessoas sabem que ela existe e sabem como acessá-la?
- Há evidência de que funciona, como redução de afastamentos ou de queixas?

Um canal de denúncia de assédio que existe no papel, nunca recebeu uma denúncia e nunca gerou consequência não é medida eficaz. Para efeito de avaliação de probabilidade, ele conta como inexistente.

As três leituras que fecham a estimativa

Leitura	O que ela responde
Frequência e intensidade	A sobrecarga é diária, semanal ou pontual? A falta de apoio da liderança é generalizada ou episódica? Existe período real de recuperação entre as exposições?
Proporção de pessoas afetadas	Qual percentual da população exposta identifica o fator como problemático? É o dado que o instrumento validado entrega com precisão estatística, e o que permite sair do achismo. Quando 70% de uma área relata sobrecarga, a probabilidade é alta. Quando são 15%, é outra conversa, ainda relevante mas de outra ordem.
Fatores de proteção	Apoio da liderança, autonomia sobre a própria tarefa, clareza de papel, equilíbrio entre vida e trabalho. A presença reduz a probabilidade. A ausência amplia.

Os cortes numéricos exatos, quais percentuais separam um nível do outro, precisam ser definidos pela organização e registrados em documento. É exatamente isso que a NR-01 chama de critério expresso.

O que questionário, escuta e observação medem

Este é o ponto que mais gera engano em campo, e ele tem uma resposta direta: os instrumentos de coleta alimentam a probabilidade, não a severidade.

A confusão é compreensível. Quando um questionário mostra que 68% de um setor relata sobrecarga, a leitura intuitiva é a de que o problema é grave. Mas o número não diz nada sobre o tamanho do dano que a sobrecarga pode causar. Ele diz que a exposição é ampla e disseminada. Isso é probabilidade.

A REGRA EM UMA LINHA

A **severidade** responde: se esse fator produzir dano, qual o tamanho do dano?

A **probabilidade** responde: qual a chance de ele produzir dano aqui, nesta organização, com estas condições e estas barreiras?

A primeira pergunta se responde com literatura, ancoragem clínica e indicadores de desfecho. A segunda se responde com o que se mede em campo.

O que cada fonte entrega

Fonte	O que ela entrega bem	O que ela não entrega
Instrumento validado Questionário	Proporção de pessoas afetadas com precisão estatística. Comparação entre setores com a mesma régua. Base para acompanhar a evolução entre ciclos.	Não explica o mecanismo. Mostra que o fator está presente, não como ele opera nem por quê.
Escuta Entrevista, grupo	O mecanismo. Como o fator se manifesta, em que momentos, o que já se tentou, por que as barreiras existentes não funcionam.	Não dá proporção. Cinco relatos consistentes não dizem se o fator atinge 10% ou 80% da área.
Observação Trabalho real	A distância entre prescrito e real. Ritmo efetivo, pausas que acontecem de fato, interrupções, condições materiais da tarefa.	Não capta o que é vivido e não é dito. E o observador altera o observado, sobretudo em ambientes com medo.
Indicadores Registros	Desfecho concreto: afastamentos por CID-F, rotatividade, absenteísmo, queixas formalizadas, benefícios do INSS.	Chega tarde. Indicador de desfecho confirma o dano depois que ele aconteceu.

Nenhuma das quatro fontes sustenta sozinha uma classificação de probabilidade alta. É a convergência entre elas que sustenta. Por isso o modelo recomendado neste material define uma **fonte de evidência mínima exigida** para cada nível: quanto mais alto o nível atribuído, mais evidência ele exige.

ONDE OS INDICADORES TOCAM A SEVERIDADE

Existe uma exceção que vale registrar, para não gerar contradição em campo. Indicadores de desfecho, como afastamentos por CID-F já concedidos ou benefícios do INSS em curso, também funcionam como âncora de severidade: eles confirmam que o dano naquela organização já atingiu determinado patamar clínico.

A diferença é o uso. Como probabilidade, o indicador conta quantas pessoas e com que frequência. Como âncora de severidade, ele confirma o tipo e a gravidade do desfecho. O mesmo dado, duas leituras. Basta declarar qual está sendo usada em cada eixo.

A matriz precisa ser assumida pela equipe técnica

Uma matriz de risco não é entregável de consultoria. É decisão técnica de quem responde pelo programa.

Consultoria oferece método, referência, instrumento e leitura dos dados. Quem adota o método, define os cortes, atribui os valores e responde por eles é a equipe técnica de segurança e saúde no trabalho da própria organização, junto com quem assina o PGR.

A distinção não é formalidade. Ela tem três consequências práticas.

Primeira: quem explica é quem assina

Diante de uma fiscalização, de uma perícia ou de uma ação trabalhista, quem é chamado a explicar por que aquele fator foi classificado como moderado é a equipe técnica da empresa. Se a resposta for que a consultoria decidiu, a classificação perde sustentação. O critério precisa estar apropriado por quem responde.

Segunda: a matriz precisa caber na realidade da organização

Um modelo 5x5 com cortes por percentual de cobertura populacional exige instrumento aplicado em amostra suficiente. Uma empresa que ainda não tem esse dado não deveria adotar uma escala que ela não consegue alimentar. Adotar uma régua que não se consegue usar produz classificação inventada, e classificação inventada é pior do que escala mais simples e honesta.

Terceira: a matriz é documento vivo

Os cortes definidos no primeiro ciclo podem se mostrar inadequados no segundo. Isso é esperado e legítimo, desde que a revisão seja registrada, justificada e datada. O que não se sustenta é mudar o critério sem registro, ou aplicar critérios diferentes a setores diferentes na mesma rodada.

O QUE SIGNIFICA ASSUMIR A MATRIZ, NA PRÁTICA

- A escolha do modelo está registrada no PGR, com a justificativa técnica de por que esse e não outro
- Os cortes de cada nível estão escritos, com os percentuais e os prazos que os definem
- A equipe técnica consegue explicar cada valor atribuído sem consultar a consultoria
- Existe registro de quem participou da atribuição dos valores e quando
- A mesma régua foi aplicada a todos os fatores e a todos os setores do ciclo
- As revisões de critério entre ciclos estão datadas e justificadas

A decisão sobre os valores é coletiva

Atribuir probabilidade e severidade envolve julgamento técnico. Julgamento individual carrega viés. A resposta a isso não é buscar objetividade impossível: é distribuir a decisão.

Quando uma pessoa sozinha classifica os fatores, três coisas acontecem com frequência. O gestor da área tende a subestimar, porque o resultado avalia indiretamente a própria gestão. O profissional de saúde tende a superestimar, porque enxerga o desfecho clínico e não a distribuição na população. E quem não conhece o processo de trabalho não consegue avaliar a intensidade real da exigência.

Quem precisa estar na mesa

Quem	O que essa pessoa enxerga que as outras não enxergam
SESMT ou responsável técnico	A coerência com o restante do PGR, a hierarquia de controles, o histórico de acidentes e a articulação com os demais riscos já inventariados.
Medicina do trabalho	Os desfechos clínicos reais daquela população, os afastamentos por CID-F, o que aparece no exame periódico e o que chega pelo atendimento.
Recursos humanos	Rotatividade, pedidos de transferência, histórico de queixas formalizadas, o que chega pela ouvidoria e o que motiva desligamentos.
Representação de quem trabalha	O trabalho real. A distância entre o que está no procedimento e o que acontece no turno. É a única fonte que corrige a leitura de quem só vê o processo de fora.
Gestão da área	As restrições operacionais, o que já se tentou mudar, o que depende de decisão fora da área e o que é possível no horizonte de prazo.

Não é preciso comitê permanente nem estrutura pesada. É preciso que a atribuição dos valores aconteça em reunião com essas leituras presentes, e que o resultado seja registrado.

Como conduzir sem que vire negociação política

- 1. Apresentar o dado antes de discutir o valor.** A leitura do instrumento, os relatos da escuta, o que a observação registrou e os indicadores de desfecho entram na mesa antes de qualquer proposta de classificação.
- 2. Aplicar a régua escrita, não a impressão.** Se o critério de P4 diz cobertura entre 50% e 75% com ao menos um indicador objetivo, a discussão é sobre se o caso atende ao critério, não sobre se parece grave.
- 3. Registrar a divergência quando ela existir.** Uma ata que diz que a medicina do trabalho sustentou S4 e o grupo decidiu S3 pelos motivos tais é mais defensável do que consenso fabricado. Divergência registrada demonstra que houve análise.
- 4. Fechar com quem assina.** A decisão é coletiva na construção. A responsabilidade técnica é de quem assina o programa, e isso não se dilui.

O QUE REGISTRAR DA REUNIÃO

Data, participantes com função e vínculo, fatores avaliados, valor atribuído a cada eixo, evidência que sustentou cada valor, divergências e o encaminhamento de cada fator para o plano de ação. Este registro é parte do PGR, não documento avulso.

As medidas de controle mudam o resultado

A empresa não é espectadora da própria matriz. O que ela já faz para reduzir o risco entra na conta, e entrar na conta é um direito técnico, não uma concessão.

Este é o ponto que mais motiva resistência interna à avaliação psicossocial. Quando a matriz só mede o problema, o resultado é sempre ruim e a organização não vê retorno do que já investiu. Quando a matriz reconhece as barreiras existentes, a avaliação vira instrumento de gestão: mostra o que funcionou, o que ficou no papel e onde vale investir no próximo ciclo.

Dois caminhos legítimos, e a armadilha entre eles

Existem duas formas correntes de fazer as medidas de controle entrarem no cálculo. As duas são defensáveis. O problema aparece quando se usa as duas ao mesmo tempo sem perceber.

Caminho	Como funciona	Vantagem e limite
A Embutido	A eficácia das medidas é um dos dois componentes da própria probabilidade, como está no subitem 1.5.4.4.5.3 da NR-01. Barreira eficaz puxa a probabilidade para baixo na hora de atribuir o nível.	É o caminho mais próximo da letra da norma e mais simples de aplicar. Em contrapartida, não deixa visível quanto da redução veio das barreiras: o efeito fica embutido em um único número.
B Residual	A probabilidade é atribuída pela exposição bruta. O resultado do cruzamento é multiplicado por um coeficiente que representa a maturidade das barreiras, produzindo o risco residual.	Torna o efeito das medidas explícito e auditável, e permite acompanhar a evolução entre ciclos. Em contrapartida, exige uma tabela de maturidade escrita e evidência para cada nível atribuído.

A ARMADILHA DA DUPLA CONTAGEM

Se a equipe atribuir probabilidade baixa *porque as barreiras funcionam* e depois ainda aplicar o coeficiente de mitigação sobre o resultado, o efeito das medidas é descontado duas vezes. O risco final sai artificialmente baixo, e essa é uma das inconsistências mais fáceis de identificar em auditoria: basta pedir a memória de cálculo.

A regra é escolher um caminho e declarar qual. Se a organização adotar o caminho B, a probabilidade precisa ser atribuída pela exposição bruta, sem desconto de barreira, e todo o efeito das medidas passa pelo coeficiente.

O que conta como barreira eficaz

Um cuidado antes da tabela: medida documentada não é medida eficaz. Para entrar no cálculo, a barreira precisa de evidência de funcionamento, não de evidência de existência. As perguntas que separam uma da outra:

- As pessoas expostas sabem que a medida existe e sabem como acessá-la?
- Existe registro de uso? Quantos atendimentos, quantas denúncias, quantos encaminhamentos?
- O uso gerou consequência rastreável, ou o caso entrou e não se sabe o que aconteceu?
- Há sinal de efeito, como redução de afastamentos, de queixas ou de rotatividade na área?

Exemplo: sobrecarga em teleatendimento

O mesmo perigo, a mesma exigência de tarefa, dois cenários de barreira. Ritmo intenso ditado por fila, metas apertadas, baixo controle sobre a própria tarefa.

Cenário A: barreiras que funcionam

Pausas reais previstas na escala e efetivamente cumpridas, com registro. Liderança formada para acolher e com autonomia para redistribuir chamados em pico. Canal de retorno onde a equipe opina sobre o fluxo, com histórico de mudanças feitas a partir dessas opiniões. Autonomia para conduzir casos complexos sem prazo de encerramento forçado.

EFEITO NA PROBABILIDADE

A exposição existe, mas há recuperação real e a barreira tem evidência de uso. A probabilidade cai.

Cenário B: barreiras no papel

Pausa prevista no procedimento mas inviável na prática, porque a fila não permite. Liderança que cobra resultado e pune erro, sem formação para o tema. Canal de retorno que existe no sistema e nunca gerou nenhuma mudança. Tempo de atendimento controlado por meta sem margem para caso complexo.

EFEITO NA PROBABILIDADE

Para efeito de avaliação, essas barreiras contam como inexistentes. A probabilidade sobe.

A diferença entre os dois cenários não está no que a empresa escreveu. Está no que ela consegue demonstrar que acontece. É por isso que a avaliação das medidas de controle precisa de evidência, e é também por isso que ela funciona como diagnóstico de gestão: ela mostra onde a política existe e não chegou ao chão.

O modelo recomendado pela Escutaris

O que segue é o modelo que a Escutaris recomenda. Ele não é oficial, porque nenhum é. É uma proposta técnica fundamentada, que a organização adota, ajusta ou substitui, desde que registre a escolha.

É um modelo 5×5 com quatro componentes: critérios de severidade em três dimensões, critérios de probabilidade em quatro dimensões com evidência mínima exigida, a matriz de cruzamento com regra de elevação, e uma tabela de barreiras de controle que produz o risco residual.

FUNDAMENTAÇÃO

ISO 45003:2021 · ISO 31000:2018 · NR-01 · NR-17 · OIT · EU-OSHA

8.1 Critérios de severidade

Avalia o impacto potencial do fator em três dimensões: saúde individual com ancoragem em CID-11, impacto organizacional e legal, e reversibilidade.

Nível	Impacto individual (saúde mental, CID-11)	Impacto organizacional e legal	Reversibilidade e temporalidade	Âncoras de referência
S1 NEGLIGÍVEL	Desconforto emocional passageiro, sem impacto funcional mensurável. Reação adaptativa normal a situação pontual.	Nenhum impacto detectável em produtividade ou clima. Sem risco de passivo legal.	Reversível em menos de 2 semanas, por autogestão. Sem necessidade de intervenção especializada.	Relatos isolados. Ausência de indicadores objetivos. Sem histórico de atendimentos ocupacionais.
S2 LEVE	Estresse moderado com duração limitada. Irritabilidade, ansiedade situacional ou insatisfação que se dissipam quando o estressor sai de cena.	Leve queda de produtividade ou engajamento. Sem afastamentos. Risco legal baixo.	Reversível de 2 semanas a 3 meses, sem intervenção especializada. Pode intensificar se o estressor persistir.	Retornos negativos esporádicos. Leve aumento de presenteísmo. Sem afastamentos por CID-F.
S3 MODERADA	Sofrimento psíquico persistente por mais de 3 meses. Sintomas subclínicos de ansiedade (F41), insônia, irritabilidade crônica, conflitos recorrentes. Ainda abaixo do limiar diagnóstico.	Absenteísmo pontual, abaixo de 5 dias por mês. Aumento de conflitos. Queda de satisfação interna. Risco incipiente de notificação trabalhista.	Reversível com intervenção especializada. Sem cuidado, pode evoluir para S4 em 3 a 6 meses.	Instrumento validado em zona de atenção. Relatos em ouvidoria ou RH. Absenteísmo crescente.
S4 GRAVE	Adoecimento mental clinicamente identificável (CID-11): TAG (F41.1), depressão (F32/F33), burnout parcial (Z73.0), TEPT (F43.1). Relatos de assédio moral ou sexual.	Afastamentos por saúde mental de 1 a 15 dias. Deterioração do clima. Alta rotatividade involuntária. Risco real de ação trabalhista e denúncia ao MTE.	Requer tratamento especializado. Recuperação parcial esperada em 3 a 12 meses. Sequelas possíveis sem tratamento.	Afastamentos por CID-F. Pedidos de transferência. Queixas formalizadas. Rotatividade acima da média do setor.
S5 CRÍTICA	Burnout grave (Z73.0 / F43.0), depressão grave (F32.2), TEPT grave. Ideação ou tentativa de autolesão. Adoecimento coletivo.	Afastamentos acima de 15 dias. Passivo judicial consolidado. Obrigação de registro no eSocial S-2240. Risco de sanção do MTE, do INSS e exposição reputacional.	Sequelas de longa duração, acima de 12 meses. Pode ser irreversível. Risco de incapacidade permanente.	Benefícios do INSS por CID-F. Múltiplas ações trabalhistas. Auditoria do MTE.

8.2 Critérios de probabilidade

Avalia frequência e abrangência em quatro dimensões: cobertura populacional, temporalidade da exposição, fonte de evidência mínima exigida e características do estressor. A quinta coluna traz o critério de exclusão, isto é, a condição que obriga a revisar o nível atribuído.

Nível	Cobertura populacional	Temporalidade da exposição	Evidência mínima exigida	Alerta e critério de exclusão
P1 IMPROVÁVEL	Menos de 10% da população exposta. Relatos isolados ou únicos.	Ocorrência esporádica ou episódica. Sem padrão identificável.	Relato verbal individual informal. Percepção sem corroboração.	Revisar com cautela se o nível se apoia apenas em relato único, sem nenhuma corroboração objetiva.
P2 POUCO PROVÁVEL	De 10% a 25% da população. Percepção restrita a subgrupo específico: turno, função, célula.	Exposição intermitente, menos de uma vez por semana. Ligada a contexto delimitado.	Relatos informais consistentes ou instrumento validado em amostra reduzida, abaixo de 30%.	Atenção se o subgrupo afetado incluir populações vulneráveis: recém-admitidos, pessoas em tratamento, retornos recentes de afastamento.
P3 POSSÍVEL	De 25% a 50% da população. Fator identificado por parte relevante da equipe ou do setor.	Exposição regular, ao menos uma vez por semana. Persistência confirmada em dois ou mais períodos.	Instrumento validado aplicado em amostra de 30% ou mais, ou dois indicadores objetivos convergentes.	Se a fonte for apenas um instrumento, sem cruzamento com indicadores, solicitar evidência adicional antes de fechar o nível.
P4 PROVÁVEL	De 50% a 75% da população. Ocorrência recorrente e disseminada em vários setores ou grupos.	Exposição crônica, acima de 3 meses contínuos. Presente em múltiplos períodos e contextos.	Instrumento validado em amostra de 50% ou mais, somado a ao menos um indicador objetivo: afastamentos por CID-F, rotatividade, queda de satisfação interna.	Se P4 não tiver evidência objetiva que o sustente, reclassificar provisoriamente como P3 e ampliar a investigação.
P5 QUASE CERTA	Acima de 75% da população. Fator sistematizado na cultura e na rotina da organização.	Exposição contínua e estrutural. Fator percebido como normal por quem trabalha.	Múltiplos instrumentos validados convergentes, somados a múltiplos indicadores objetivos críticos: INSS, ações trabalhistas.	P5 exige notificação formal no PGR e no eSocial (S-2240) e intervenção prioritária com comitê multidisciplinar.

SOBRE OS INSTRUMENTOS VALIDADOS

A régua acima não amarra um instrumento específico. Na prática a Escutaris trabalha com HSE Management Standards, ESCAM, JSS e o modelo demanda-controle de Karasek, ERI e SSOS, combinados conforme o perfil da organização. Instrumentos de rastreio clínico, como MBI e PHQ-9, entram como âncora de severidade quando há indicação técnica, não como medida de exposição.

O que a régua exige é que o instrumento seja validado, que a amostra atinja o percentual mínimo do nível pretendido e que a escolha esteja registrada no PGR.

8.3 A matriz 5×5

Score bruto igual a severidade multiplicada por probabilidade, com resultado de 1 a 25.

 BAIXO (1 a 4)  MODERADO (5 a 9)  ALTO (10 a 15)  CRÍTICO (16 a 25)

Severidade ↓ / Probabilidade →	P1 Improvável < 10%	P2 Pouco provável 10 a 25%	P3 Possível 25 a 50%	P4 Provável 50 a 75%	P5 Quase certa > 75%
S5 CRÍTICA Burnout grave, adoecimento coletivo, judicialização	5 MODERADO	10 ALTO *	15 ALTO *	20 CRÍTICO	25 CRÍTICO
S4 GRAVE Adoecimento CID-11, afastamento, assédio	4 BAIXO	8 ALTO *	12 ALTO *	16 CRÍTICO	20 CRÍTICO
S3 MODERADA Sofrimento persistente (> 3 meses), conflitos	3 BAIXO	6 MODERADO	9 MODERADO	12 ALTO	15 ALTO
S2 LEVE Estresse moderado (< 3 meses), leve queda de engajamento	2 BAIXO	4 BAIXO	6 MODERADO	8 MODERADO	10 ALTO
S1 NEGLIGÍVEL Desconforto pontual (< 2 semanas), sem impacto	1 BAIXO	2 BAIXO	3 BAIXO	4 BAIXO	5 MODERADO

REGRA DE ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA

Combinações de severidade S4 ou S5 com probabilidade P2 ou superior são classificadas **no mínimo como ALTO**, marcadas com asterisco na matriz, independentemente do score numérico. A razão é a irreversibilidade dos danos graves à saúde mental: um quadro que pode deixar sequelas não deve cair em faixa de baixa prioridade só porque atinge poucas pessoas. Fundamentação: ISO 45003:2021, item 6.1.2.

Resposta esperada por nível

Nível	Faixa	Resposta esperada
BAIXO	1 a 4	Manter as práticas atuais e monitorar no ciclo seguinte. Não exige ação imediata, exige vigilância.
MODERADO	5 a 9	Ação programada. Medidas preventivas com prazo médio no plano de ação, com responsável e data definidos.
ALTO	10 a 15	Ação prioritária. Medidas de prazo curto a médio, com acompanhamento entre ciclos e indicador de verificação.
CRÍTICO	16 a 25	Ação imediata. Pode exigir alteração das condições de trabalho no curto prazo, comitê multidisciplinar e notificação formal.

8.4 Barreiras de controle e risco residual

Esta é a tabela que operacionaliza o caminho B descrito na seção 7. O coeficiente de mitigação é aplicado sobre o score bruto para obter o risco residual. Atribua sempre o nível mais conservador que satisfaça **todos** os critérios e a evidência mínima exigida.

Risco residual = (probabilidade × severidade) × coeficiente de mitigação

Nível	Coef.	Tipo ISO 45003	CrITÉrios de atribuiÇão	Exemplos de medidas	Prazo esperado de implantaÇão
N0 SEM CONTROLE	1,00	Nenhuma	Nenhuma barreira formal ou informal identificada para o fator. O risco é gerenciado por acaso ou pela resistência individual de quem trabalha.	Ausência de política, de canal de escuta e de protocolo de saúde mental. Gestão sem orientação sobre o tema.	Não se aplica
N1 REATIVO	0,80	Terciária isolada, reativa	Apenas medidas individuais pontuais, sem sistematização. Atuação depois do dano manifestado. Encaminhamentos sem rastreamento nem protocolo.	Canal informal com o RH, sem protocolo. Encaminhamento individual a psicólogo sem acompanhamento de retorno. Sem programa de apoio formalizado.	Imediato, já existe sem estrutura
N2 BÁSICO	0,60	Terciária sistematizada	Suporte individual formalizado e documentado. Canal de atendimento ativo com protocolo. Sem intervenção sobre a organização do trabalho. Reduz severidade, não reduz probabilidade.	Programa de apoio operacional. Profissional de psicologia disponível. Protocolo de retorno ao trabalho após afastamento por saúde mental. Registro de atendimentos no PGR.	1 a 3 meses para formalização completa
N3 INTERMEDIÁRIO	0,40	Secundária e terciária	Políticas formais implantadas, formação de gestores em saúde mental e suporte individual sistematizado. Monitoramento periódico com indicadores definidos. Ainda sem redesenho da fonte do estressor.	Política contra assédio publicada e conhecida. Formação de liderança aplicada periodicamente. Programa de apoio com indicadores de uso. Canal de denúncia com rastreamento.	3 a 6 meses para implantação completa
N4 AVANÇADO	0,20	Primária, secundária e terciária	Hierarquia completa de controles: intervenções que reduzem o estressor na fonte, controles de processo e suporte individual. Ciclo formal de avaliação e melhoria, com indicadores monitorados.	Revisão de cargas e ritmos com participação de quem trabalha. Revisão da organização em turnos. Liderança avaliada por múltiplas fontes. Comitê de saúde mental ativo. Indicadores integrados ao PGR e reavaliação semestral.	6 a 12 meses para o ciclo completo
N5 SISTÊMICO	0,10	Primária, secundária, terciária e sistema de gestão	Gestão plena dos riscos psicossociais integrada ao sistema de gestão, ao PGR e ao eSocial. Evidência demonstrada de redução do risco ao longo do tempo. Reavaliação periódica com métricas validadas e auditoria interna.	Todos os itens do N4, somados a autoavaliação ou certificação ISO 45003. Indicadores de saúde mental no painel de SST. Relatório anual publicado. Registro no eSocial S-2240 e evidência de tendência de queda dos afastamentos por CID-F.	12 a 24 meses até a maturidade

DOIS CUIDADOS AO APLICAR O COEFICIENTE

Primeiro: se a organização adotou o caminho B, a probabilidade precisa ter sido atribuída pela exposição bruta. Descontar a barreira nos dois lugares zera a utilidade do resultado.

Segundo: a regra de elevação automática vale sobre o score bruto e não é anulada pelo coeficiente. Um fator S5 com P3 permanece no mínimo em ALTO, mesmo que o risco residual calculado caia abaixo da faixa. O que o coeficiente demonstra é o efeito da gestão, não o desaparecimento do perigo.

Três casos aplicados

Os casos abaixo percorrem o caminho completo: o que foi identificado, o que sustenta cada valor, o resultado e a resposta. São exemplos de aplicação da régua, não recomendações para situações específicas.

Caso 1: assédio moral em setor de cobrança

Gestor usa linguagem humilhante em reuniões de equipe. A escuta registra constrangimentos públicos frequentes, confirmados por relatos convergentes de pessoas de turnos diferentes. Existe canal de denúncia no sistema, que nunca recebeu registro e nunca gerou consequência. O instrumento aplicado cobriu 62% da área e apontou o fator como crítico. Há duas queixas formalizadas no RH e rotatividade acima da média do setor.

SEVERIDADE

S4 GRAVE. Assédio moral com relatos de constrangimento sistemático, com potencial de depressão, TEPT e burnout. Âncora: queixas formalizadas e rotatividade acima da média.

PROBABILIDADE

P4 PROVÁVEL. Cobertura de 62%, exposição crônica e recorrente, instrumento validado somado a indicador objetivo. O canal de denúncia inoperante conta como barreira inexistente.

SCORE BRUTO

$4 \times 4 = 16$

BARREIRAS (N)

N0. O canal existe no sistema mas não tem uso, protocolo nem consequência rastreável. Não conta como barreira. Coeficiente 1,00.

RISCO RESIDUAL

$16 \times 1,00 = 16$

NÍVEL CRÍTICO · Ação imediata

RESPOSTA

Apuração formal com afastamento preventivo do gestor da função durante a investigação. Ativação efetiva do canal, com protocolo, prazo e rastreamento. Comunicação a toda a área sobre o processo em curso e sobre onde registrar. Registro no PGR e avaliação da obrigação de notificação no eSocial.

Caso 2: baixa clareza de papel em empresa de tecnologia

A empresa cresceu rápido e os papéis não foram redefinidos. A escuta mostra pessoas recebendo demanda de vários gestores sem hierarquia clara de prioridade. O instrumento cobriu 78% da população e 40% indicou não saber a quem recorrer diante de conflito de prioridades. Não há afastamentos por CID-F na área. A direção reconhece o problema e já iniciou revisão de organograma.

SEVERIDADE

S3 MODERADA. Sofrimento persistente com sintomas subclínicos de ansiedade e insatisfação, sem quadro clínico identificado nem afastamento.

PROBABILIDADE

P3 POSSÍVEL. O fator foi identificado por 40% da população, dentro da faixa de 25% a 50%. Exposição regular e confirmada. Instrumento validado com amostra acima de 30%.

SCORE BRUTO

$$3 \times 3 = 9$$

BARREIRAS (N)

N3. Há política formal, formação de liderança em curso e revisão de organograma iniciada com monitoramento. Ainda sem redesenho concluído. Coeficiente 0,40.

RISCO RESIDUAL

$$9 \times 0,40 = 3,6$$

BRUTO MODERADO · RESIDUAL BAIXO · Ação programada, com verificação

RESPOSTA

Revisão das descrições de cargo em 60 dias e definição de estrutura de reporte em 30 dias. O residual baixo reflete ação já em curso e não dispensa a verificação: se a revisão não se concluir no prazo, o coeficiente volta a N2 no próximo ciclo e o nível sobe.

Caso 3: sobrecarga em equipe de atendimento

Equipe de cinco pessoas perdeu dois integrantes por desligamento há quatro meses e segue com o mesmo volume de chamados. Média de 30% de horas extras por mês nos últimos três meses. Três afastamentos por ansiedade nos últimos seis meses, com CID-F. O instrumento cobriu 100% da equipe e todos apontaram sobrecarga. Não há medida preventiva implantada.

SEVERIDADE

S4 GRAVE. O adoecimento já se materializou: três afastamentos por CID-F em seis meses, na faixa de 1 a 15 dias. Não é risco potencial, é dano em curso.

PROBABILIDADE

P5 QUASE CERTA. Cobertura acima de 75%, exposição contínua e estrutural, instrumento convergente com múltiplos indicadores objetivos: horas extras, afastamentos, rotatividade.

SCORE BRUTO

$4 \times 5 = 20$

BARREIRAS (N)

N0. Nenhuma medida implantada para o fator. Coeficiente 1,00.

RISCO RESIDUAL

$20 \times 1,00 = 20$

NÍVEL CRÍTICO · Ação imediata

RESPOSTA

Recomposição da equipe em caráter emergencial. Redistribuição temporária de carga entre áreas enquanto a contratação não se conclui. Revisão das metas durante o período de transição. P5 exige notificação formal no PGR e no eSocial (S-2240) e comitê multidisciplinar de acompanhamento.

O QUE OS TRÊS CASOS MOSTRAM JUNTOS

No caso 1 e no caso 3 a severidade é a mesma, S4, e a resposta é a mesma, ação imediata. Mas por caminhos diferentes: um pela ausência total de barreira diante de exposição disseminada, outro pelo dano já materializado em afastamentos. No caso 2 o score bruto e o residual divergem, e é justamente essa divergência que dá o que gerenciar. Ela mostra que a ação em curso está produzindo efeito e define o que precisa ser verificado no ciclo seguinte.

O que precisa estar escrito

Checklist do que a NR-01 exige que esteja expresso em documento. Se algum item não puder ser respondido a partir do PGR, ele é uma lacuna.

Sobre o método escolhido

- ☐ Qual modelo de matriz foi adotado, com o número de níveis em cada eixo
- ☐ Por que esse modelo, com a justificativa técnica da escolha
- ☐ Qual referência normativa e técnica sustenta o modelo
- ☐ Se a organização adotou o caminho A ou o caminho B para as medidas de controle, e a declaração explícita de que não se aplica os dois

Sobre os critérios

- ☐ A escala de severidade completa, com a descrição de cada nível
- ☐ A escala de probabilidade completa, com os cortes numéricos de cada nível
- ☐ A evidência mínima exigida para atribuir cada nível de probabilidade
- ☐ As faixas de classificação resultantes do cruzamento
- ☐ Qualquer regra de exceção adotada, como a elevação automática, com a razão técnica
- ☐ A tabela de maturidade de barreiras e os coeficientes, se o caminho B for o adotado

Sobre a aplicação

- ☐ Quais instrumentos foram aplicados, com qual cobertura e em que período
- ☐ Como a escuta e a observação foram conduzidas e o que registraram
- ☐ Quais indicadores objetivos foram consultados
- ☐ O valor atribuído a cada fator em cada eixo, com a evidência que o sustenta

Sobre a decisão

- ☐ Data da reunião de classificação e participantes, com função e vínculo
- ☐ Divergências registradas e como foram resolvidas
- ☐ Quem assina tecnicamente a classificação
- ☐ O encaminhamento de cada fator para o plano de ação, com responsável e prazo

Sobre a continuidade

- ☐ Quando será a próxima reavaliação e o que a dispara antes do prazo
- ☐ Que indicadores serão acompanhados entre ciclos
- ☐ Se houve mudança de critério em relação ao ciclo anterior, qual, quando e por quê

Registrar não é burocracia. É o que transforma uma classificação em decisão técnica sustentável.

REFERÊNCIAS

Fundamentação técnica

- **BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego.** Norma Regulamentadora nº 1: Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Redação dada pela Portaria MTE nº 1.419, de 27 de agosto de 2024. Vigência das disposições sobre fatores psicossociais prorrogada para 26 de maio de 2026 pela Portaria MTE nº 765, de 15 de maio de 2025. Ver especialmente o subitem 1.5.4.4.5.3, que estabelece os dois critérios de avaliação da probabilidade para riscos psicossociais.
- **BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego.** Guia de informações sobre os Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho (NR-1 Gerenciamento de Riscos Ocupacionais). Brasília, 2025. Detalha como a organização deve estabelecer critérios de severidade, probabilidade e níveis de risco para o inventário de perigos do GRO.
- **INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION.** ISO 45003:2021: Occupational health and safety management. Psychological health and safety at work. Guidelines for managing psychosocial risks. Genebra, 2021. Diretriz principal para o gerenciamento de riscos psicossociais. O item 6.1.2 fundamenta a regra de elevação automática adotada no modelo recomendado.
- **INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION.** ISO 31000:2018: Risk management. Guidelines. Genebra, 2018. Base metodológica para a construção de critérios de risco e para a distinção entre risco bruto e risco residual.
- **FACAS, Emílio Peres.** Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho: contribuições da psicodinâmica do trabalho. Tese de doutorado, Universidade de Brasília, Brasília, 2013. Propõe o PROART e demonstra como a organização do trabalho prediz o sofrimento patológico e os danos psicossociais.
- **DNV.** ISO 45003:2021 Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho. Saúde e Segurança Psicológica no Trabalho: orientações para a gestão dos riscos psicossociais. São Paulo, 2026. Notas de aula.
- **ERGOADAPT.** Matriz de Risco. Salvador, notas de aula.
- **BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego.** Norma Regulamentadora nº 17: Ergonomia. Referência para a avaliação das exigências da atividade e para a distinção entre trabalho prescrito e trabalho real.

NOTA SOBRE O ALCANCE DESTES MATERIAIS

Este documento é de apoio técnico e trata de método de avaliação. Ele não substitui a análise ergonômica preliminar, a avaliação de cada posto de trabalho, o julgamento de quem assina o programa nem orientação jurídica. As classificações apresentadas nos casos são exemplos de aplicação da régua, construídos para fins didáticos.